جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجلاء فتحي محروس فرج
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الزاويه الحمراء **العنوان :** حشاد
رقم البطاقة : 27904130102946 **رقم التليفون :** 01013265738 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 13-04-1979 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجلاء فتحي محروس فرج
National ID: 27904130102946

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

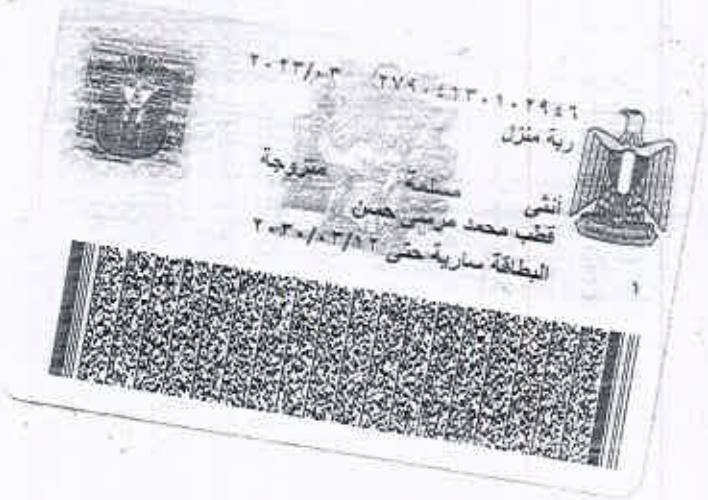
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: [illegible]	Request No.	: 13002426
Patient No.	: 27904130102946	Request Date	: 15/02/2025
Path No.	: 653/25	Verification Date	: 08/03/2025
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible]
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed

Pathology Report

Microscopic examination:
- Wide local excision and sentinel lymph node biopsy specimens:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: Not detected.
- Perineural invasion : Not detected.
- Ductal carcinoma in situ: focal intermediate grade (solid and cribriform).
- Lymph node involvement: Free SLNs (0/5).
- Resection Margins: Free all resected margins.
- Hysterectomy:

Sections examined from endometrium revealed tubular and dilated glands lined by pseudostratified columnar epithelium without atypia dispersed in spindle cell stroma. Cervix showed infiltration by nonspecific inflammatory cell infiltrate. Multiple leiomyomas formed of intersecting bundles of smooth muscle fibers within a fibrous stroma with no mitosis, necrosis or atypia. Left ovary showed corpus luteum. Right ovary and both tubes are unremarkable.

Diagnosis:
Left breast mass, wide local excision and sentinel lymph node biopsy specimens:
-Invasive duct carcinoma , grade II with intermediate grade DCIS .
-Free all resected margins.
-Free SLNs (0/5).
-Stage : pT2 , pN0.
Hysterectomy:
- Simple endometrial hyperplasia without atypia .
- Multiple benign leiomyomas.
- Left ovary showed corpus luteum.

Verified by :
Dr.Menan Hossam

CAP
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: نجلاء فتحي محروس فرج **MR. :** 5811	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 47-year-old individual with a luminal breast cancer phenotype who underwent total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy (TAH-BSO) and right breast segmental mastectomy (RT-BSC) in February 2025. Pathology staged the disease as T2 N0. The treatment plan included adjuvant chemotherapy with placement of a port, followed by endocrine therapy with ARAMIDEX and bone-protective therapy with ZOMETA. In March 2026, the patient was noted to be free of ARAMIDEX and supportive care, and a three-month course of ZOMETA was scheduled to commence on 14 June 2026 after laboratory evaluation.

The patient has a history of left breast cancer treated with left breast-conserving surgery (BCS) on 15 February 2022, pathology revealing a grade 2 tumor, node-negative (pT2 N0) invasive ductal carcinoma, estrogen-receptor score 8/8, progesterone-receptor score 8/8, and HER2-negative status. The patient was recommended to receive four cycles of taxane-based chemotherapy (4 TC) and to start ARAMIDEX in August 2025. As of 14 March 2026, imaging was classified as BIRADS 2, and the patient continues on ZOMETA and ARAMIDEX as part of ongoing management.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : اسماء محمد مصطفي نصر

يعتمد ,

Patient Name: Naglaa Fathy Mahrous Farag	Date : 23/12/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 4510/2024	Pat. ID: 95836

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

***reported case of left breast cancer:**

1. *Chest:*
- Bilateral enlarged axillary level I and II lymph nodes the largest at left side measures 1.5X1 cm.
- Few bilateral scattered tiny pulmonary nodules, the largest is noted at lateral segment of middle lung lobe measuring 5 mm.
- Multiple prominent mediastinal lymph nodes, the largest at paratracheal region measures 1X0.9cm.
- Multiple subpleural atelectatic bands at middle lobe
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.

2. *Abdomen and pelvis:*
- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Right renal well-defined hypodense lesion is seen measuring about 4.2X4.8 cm.
- Otherwise normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, and both supra-renals.
- Enlarged right external iliac lymph node measures about 3x 1.6 cm with prominent portocaval , para-aortic and left iliac lymph nodes , yet the largest seen portocaval measures about 1.6x 1 cm
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus is seen.

3. *The scanned skeleton:*
- Few dorsolumbar tiny lytic lesions are seen.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name	: الأستاذة / نجلاء فتحي محروس إدريس	Request No.	: 13004115
Patient No.	: 27904130102946	Request Date	: 04/11/2024
Path No.	: 4251/24	Verification Date	: 13/11/2024
Sex	: Female	Financial Category	: هيئة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed yo

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy.

Gross Examination:
- Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Ductal carcinoma in situ: Focal DCIS.
- Perineural invasion: Not detected.
- Angioinvasion: Not detected.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma G II with focal DCIS.

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar
Dr.Menna Nabil

Verified by :

CAP
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]